



PATOLOGÍA	GENERALIDADES	CLÍNICA Y EXAMEN FÍSICO	ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS	TRATAMIENTO																																												
Artritis reumatoide	Enf. inflamatoria crónica sistémica. 0,5-1% de adultos en el mundo. + frec entre 35-45 años. Etiología: - Desconocida. Fisiopatogenia: - Factor gatillo +predisposición genética → rta inmunitaria con prod. de Acs → infiltración sinovial x LT y monocitos → tejido de granulación (pannus) → manifestaciones. FR: - Ambientales: sílice, infecciones (VEB...), alt microbiota. - Hormonales: sexo F, nuliparidad, enf. tiroidea. - Modificables: TBQ, alcohol, obesidad, DBT. - Genéticos: familiar directo con AR, HLA DR4, HLA DRB1. Clasificación: - Con > 6 puntos - Al menos 1 artíc con sinovitis - Que no se explique x otra enf <table><tr><th colspan="2">Diagnóstico-Criterios de clasificación de la EULAR/ACR 2010</th></tr><tr><th colspan="2">A. Afectación articular</th></tr><tr><td>1 articulación grande afectada</td><td>0</td></tr><tr><td>2-10 articulaciones grandes afectadas</td><td>1</td></tr><tr><td>1-3 articulaciones pequeñas afectadas (con o sin afectación de grandes articulaciones)</td><td>2</td></tr><tr><td>4-10 articulaciones pequeñas afectadas (con o sin afectación de grandes articulaciones)</td><td>3</td></tr><tr><td>>10 articulaciones (al menos una pequeña)</td><td>5</td></tr><tr><th colspan="2">B. Serología (al menos se necesita un resultado)</th></tr><tr><td>FR y anti-PCP negativos</td><td>0</td></tr><tr><td>FR y/o anti-PCP positivos bajos (<3 valor normal)</td><td>2</td></tr><tr><td>FR y/o anti-PCP positivos altos (>3 valor normal)</td><td>3</td></tr><tr><th colspan="2">C. Reactantes de fase aguda</th></tr><tr><td>VSG y PCR normales VSG y/o PCR elevadas</td><td>0</td></tr><tr><td></td><td>1</td></tr><tr><th colspan="2">D. Duración de los síntomas</th></tr><tr><td><6 semanas</td><td>0</td></tr><tr><td>≥6 semanas</td><td>1</td></tr></table>	Diagnóstico-Criterios de clasificación de la EULAR/ACR 2010		A. Afectación articular		1 articulación grande afectada	0	2-10 articulaciones grandes afectadas	1	1-3 articulaciones pequeñas afectadas (con o sin afectación de grandes articulaciones)	2	4-10 articulaciones pequeñas afectadas (con o sin afectación de grandes articulaciones)	3	>10 articulaciones (al menos una pequeña)	5	B. Serología (al menos se necesita un resultado)		FR y anti-PCP negativos	0	FR y/o anti-PCP positivos bajos (<3 valor normal)	2	FR y/o anti-PCP positivos altos (>3 valor normal)	3	C. Reactantes de fase aguda		VSG y PCR normales VSG y/o PCR elevadas	0		1	D. Duración de los síntomas		<6 semanas	0	≥6 semanas	1	Manif. Articulares: POLIARTRITIS SISTÉMICA DE PEQUEÑAS ARTICULACIONES (interfalángicas proximales, metacarpofalángicas, muñecas, metatarsofalángicas...). <i>NUNCA compromete IF distales.</i> Se ven + en mano hábil. Rigidez matinal > 1hr, inicio gradual - Dificultad para cerrar el puño. - Deformidad “en cuello de cisne”, deformidad “en ojal” (Boutonniere), pulgar “en Z”. - Desviación cubital o “mano en ráfaga”. - Carpo “en tecla de piano”. - Puede haber subluxación de la articulación atlantoaxoidea → dolor cervical, parestesias. - Dedos en martillo (pie). Manif. Sistémicas no específicas: - Rta hepática de fase aguda (anemia, amiloidosis, cambios en prots plasmáticas). - Inmunoactivación LT/B inespecífica (hipergamaglobulinemia policlonal, inmunodeficiencia...). - Metabólicos (cambios perfil lipídico, insulino-rresistencia, aum riesgo CV aterotrombótico). - Óseos (osteoporosis, retraso del crecimiento). - Eje hipotálamo-suprarrenal (astenia). Hematológicas: - Grales: ↑VSG, ↑PCR, anemia, trombocitosis. - Específicas: FR +, Ac anti CCP +. - Sme de Felty: AR + esplenomegalia + leucopenia Nódulos reumatoideos (+ en zonas de P) SC o viscerales. Oculares: - Queatoconjuntivitis seca, epiescleritis, escleritis. - Escleromalacia perforante. Pleuropulmonares: Pleuritis, derrame pleural (DD con TBC). - Nódulos pulmonares, enf intersticial pulmonar. Sme Caplan: AR + nódulos pul. + neumoconiosis Neurológicas: - Mecánicas (x lesiones estructurales). - Vasculitis (x la inflamación). CV (1° causa de muerte en AR): - Pericarditis. - Vasculitis reumatoide (arteritis distal, hrr periungueales, infartos digitales, gangrena, etc). EJ: sme del túnel carpiano	LAB (marcadores serológicos solo p/dx, no para seguimiento) FR AntiCCP - VHS, PCR → p/eval severidad RX - Se ven dp de 6m del inicio de la enfermedad. - Precoz (“chismosas”): apófisis estiloide del cúbito, 5° artic MTF. - Inicial: - Edema partes blandas, osteopenia yuxtaarticular, Pinzamiento SIMÉTRICO, erosiones en sacabocado. - Pérdida simétrica de cartílago (DD con artrosis). - Tardío: anquilosis, deformidad. RMN - Poco uso. - Detección precoz. - P/detectar sinovitis, tendinopatías, edema óseo. ECO - P/evaluar sinovitis con escala de grises.	OBJETIVOS: alcanzar REMISIÓN, aliviar el dolor, ↓inflamación, prevenir la destrucción articular, preservar capacidad funcional. FARMACOLÓGICO AINES (Diclofenac, Ibuprofeno, Naproxeno). ↓ dolor en inflamación. Corticoides (Prednisona 5-10 mg VO) ↓ inflam, dolor y DAÑO ARTICULAR en los 1ros años de la enf (progresión + lenta). - Uso 2-6m como terapia puente con DMARDs. DMARDs (clásicos) (<i>ver cuadro fco drogas antirreumáticas</i>) - Remisión 70%. Uso desde el dx. Serología previa. - Metotrexate (7,5-25 mg/sem) + ác. Fólico (1/3 de la dosis de MTX). - Sulfasalazina (2-3gr/d). - Leflunomida (20 mg/d) → carga: 100 mg/d x 3d. - Hidroxicloroquina (400 mg/d) → en gral combinada con MTX. Agentes biológicos (VO) Anti TNF-alfa (Etanercept, Infliximab, Adalimumab, Certolizumab, Golimumab). - Anti CTLA-4 (Abatacept). - Anti LB CD20 (Rituximab). - Anti IL-1 (Anakinra). - Anti IL-6 (Tocilizumab, Sarilumab). - Inhibidores JAK: Tofacitinib, Baracitinib, Uparda... <table><tr><th>Indicaciones</th><th>Contraindicaciones</th></tr><tr><td>Falta de rta a 2 DMARDs (1 es MTX).</td><td>Inf activas/latentes.</td></tr><tr><td>Enf activa (DAS 28 >5,1 (sin activ: <2,7))</td><td>Enf desmielinizante.</td></tr><tr><td></td><td>Insuf cardíaca (FE <40%).</td></tr><tr><td></td><td>CA en los últimos 5 años.</td></tr></table> Esquema típico de inicio: MTX 10 mg/ sem (con escalada rápida de dosis: 15mg a las 2 sem, 20 mg al mes y medio...) Prednisona 5-10 mg/d AINES a demanda - Evaluar rta a las 6 sem. - Si no hay remisión a las 12 sem: agregar otro DMARD. NO FARMACOLÓGICO - Reposo en agudo, ejercicio fuera de la crisis. Cxs. Seguimiento: ideal c/3 meses. En gran c/6 meses, Rx anual.	Indicaciones	Contraindicaciones	Falta de rta a 2 DMARDs (1 es MTX).	Inf activas/latentes.	Enf activa (DAS 28 >5,1 (sin activ: <2,7))	Enf desmielinizante.		Insuf cardíaca (FE <40%).		CA en los últimos 5 años.
Diagnóstico-Criterios de clasificación de la EULAR/ACR 2010																																																
A. Afectación articular																																																
1 articulación grande afectada	0																																															
2-10 articulaciones grandes afectadas	1																																															
1-3 articulaciones pequeñas afectadas (con o sin afectación de grandes articulaciones)	2																																															
4-10 articulaciones pequeñas afectadas (con o sin afectación de grandes articulaciones)	3																																															
>10 articulaciones (al menos una pequeña)	5																																															
B. Serología (al menos se necesita un resultado)																																																
FR y anti-PCP negativos	0																																															
FR y/o anti-PCP positivos bajos (<3 valor normal)	2																																															
FR y/o anti-PCP positivos altos (>3 valor normal)	3																																															
C. Reactantes de fase aguda																																																
VSG y PCR normales VSG y/o PCR elevadas	0																																															
	1																																															
D. Duración de los síntomas																																																
<6 semanas	0																																															
≥6 semanas	1																																															
Indicaciones	Contraindicaciones																																															
Falta de rta a 2 DMARDs (1 es MTX).	Inf activas/latentes.																																															
Enf activa (DAS 28 >5,1 (sin activ: <2,7))	Enf desmielinizante.																																															
	Insuf cardíaca (FE <40%).																																															
	CA en los últimos 5 años.																																															
Artritis reactivas	Artritis reactiva aséptica post infección (en gral GI o GU: uretritis, salmonelosis). Etiología: chlamydia t., Yersinia, Salmonella, Shigella, Campylobacter, etc	Artritis reactiva + conjuntivitis + uveítis = sme de Reiter. Periférica: en gral patrón mono/oligo articular de grandes articulaciones que afecta MMII. Axial: sacroileítis clínica, entesitis, dactilitis. Extraarticulares: fiebre/malestar, sme miccional, úlceras mucosas, queratodermia blenorragica, conjuntivitis/uveítis	Cultivos de heces/muestra orina/vaginal ↑ VCG y PCR FR y AntiCCP --	Tto sintomático: AINES, corticoides → la mayoría se recupera. Refractariedad: DARMES, anti TNF-alfa. Buen pronóstico, remisión espontánea a 6-12 m del inicio.																																												

EASN	Características compartidas: Compromiso AXIAL (+ sacroilíaco) Compromiso perif ASIMÉTRICO (+ MMII) FR mayormente negativo Compromiso OCULAR frecuente Asociación con el HLA B27	Criterios ASAS para la clasificación de espondiloartritis axial y periférica (EsP):						
		AXIAL		PERIFÉRICA				
		En ptes con dolor lumbar >= 3 meses y edad de inicio < 45 años		Artritis o entesitis o dactilitis, y:				
		Sacroilitis en imagen y >1 de estas:	O HLA B27 y >= 2 de estas:	>= 1 característica de EsP:	O >= 2 características de EsP:			
		Dolor lumbar inflamatorio Artritis Entesitis (talón) Uveítis Dactilitis Psoriasis Enf Crohn/colitis ulcerosa Buena rta a AINEs Historia familiar para SpA HLA B27 PCR elevada	Sacroilitis en imagen: - Inflamación activa (aguda) en RM altamente sugestiva de sacroilitis asociada a EsP. - Sacroilitis radiográfica definida según criterios del NY modificados.	Uveítis Psoriasis Enf de Crohn/colitis ulcerosa Infección previa HLA B27	Artritis Entesitis Dactilitis Dolor lumbar inflamatorio (alguna vez) Historia familiar para EsP			
Espondilitis anquilosante	Afecta ppalmente esqueleto axial y entesis. Pérdida acelerada y progresiva de la movilidad de la COLUMNA. + hombres 3:1, entre 20-40 años. Criterios de clasificación (1 de cada): <table><tr><td>Clínicos</td><td>Radiológicos</td></tr><tr><td>Dolor lumbar x 3 m inflamatorio. Limitación de la movilidad de la columna lumbar. Expansión del tx disminuida.</td><td>Sacroileítis unilat grados 3-4 Sacroileítis bilat en grados 2-3-4.</td></tr></table>	Clínicos	Radiológicos	Dolor lumbar x 3 m inflamatorio. Limitación de la movilidad de la columna lumbar. Expansión del tx disminuida.	Sacroileítis unilat grados 3-4 Sacroileítis bilat en grados 2-3-4.	DOLOR LUMBAR INFLAMATORIO Inicio en adolescencia, lumbar bajo-glúteos-cadera, peor en la noche, rigidez matinal, buena rta a AINEs, sacroileítis simétrica. EE: test de Schober, distancia occipucio-pared, distancia dedo medio-piso, expansión torácica. - Posición final: “del esquiador” Artritis periférica: oligoartritis asimétrica (ppal en MMII). Entesitis, bursitis, dolor tx. Uveítis anterior aguda (iritis o iridociclitis) en algún momento de su vida. Unilateral, autolimitada, recurrente. Complicaciones crónicas: - Espondilodiscitis (lesión de Andersson). - Osteoporosis acelerada. - Fracturas espinales. - Subluxación AA.	LAB HLA B27 + (en el 90-95%) RX - Sacroileítis - Espondilitis - Entesitis RMN - Dx precoz (STIR → secuencia para ver edema). - Si se puede hacer de entrada, hacer.	NO FARMACOLÓGICO - FUNDAMENTAL - Educación, ejercicios (natación, pilates), fisioterapia, grupos de autoayuda. FARMACOLÓGICO AINEs a DIARIO, la menor dosis posible. - Corticoides no se usan, solo infiltración local. - DMARDs → discutidos en compromiso axial. A veces se los usa como puente para el biológico con las obras sociales. - En compromiso periférico: Sulfasalazina, MTX. - Biológicos: Anti TNF-alfa o Anti IL-17, cuando: - Falla a 2 AINEs durante 3 meses, índice enf >4. QUIRÚRGICO - Reemplazo protésico, corrección postural, urgencias neurológicas.
Clínicos	Radiológicos							
Dolor lumbar x 3 m inflamatorio. Limitación de la movilidad de la columna lumbar. Expansión del tx disminuida.	Sacroileítis unilat grados 3-4 Sacroileítis bilat en grados 2-3-4.							
Artritis psoriásica	Enf inflam articular asoc con psoriasis . En 30% de los ptes con psoriasis. H = M, entre 30-55 años. Criterios de clasificación: - Enf articular inflam + 3p de: - Psoriasis (2p) - Psoriasis ungueal (1p) - FR – (1p) - Dactilitis (1p) - Neoformación ósea yuxta-articular rx (1p)	Tríada de la Aps: Oligoartritis asimétrica mixta + entesitis + dactilitis Artritis de predominio IFDs → ÚNICO de la Aps. - En 15% de los casos. - Poliartritis simétrica (5%) → evolución + frec. - Compromiso espondilítico (DD con EA), (5%). - Artritis mutilante (5%) → forma + agresiva. - Edema periférico (+ MMII) (DD con patol. CV). - Sme SAPHO. - Manif. Cutáneas de psoriasis (gutata, etc). - Uveítis (20%), compromiso CV y de tx, etc.	LAB - FR – (en el 90%) - HLA B27 + (en el 25%) - Hiperuricemia (DD con gota) SIEMPRE solicitar HIV RX (simple de mano/pie) - Neoformación ósea yuxtaarticular: osificación mal definida. - Periostitis - Osteólisis “pencil and cup”	Sintomático: AINEs. - Corticoides (cuidado xq empeoran la piel). Enfermedad: - MTX, leflunamida, sulfasalazina. - Ciclosporina (p/extensión cutánea severa: eritrodermia psoriásica). - Biológicos (para casos refractarios).				
Artropatías enteropáticas	Oligoartritis asimétrica + FR (-) + Enf GI (EII, Whipple, celiaquía, cx bypass GI). H = M	Oligoartritis asimétrica (asoc. a Whipple es simétrica 80%). EII (Crohn → + periférico / CU → + axial) Entesitis, sacroileítis, uveítis, eritema nudoso, pioderma gangrenoso.	LAB - FR – - HLA B27 + (10%)	AINEs Sulfasalazina (elección → xq tb actúa en el intestino), MTX, bio... Asoc a Whipple → tetraciclinas x 1 año.				
Espondiloartritis reactiva (Enf. de Reiter)	Sinovitis x infección + conjuntivitis + uretritis y/o cervicitis. Infección; salmonella (GI), chlamydia (GU), HIV, etc. + hombres (8:1), 20-30 años.	Monoartritis de rodilla, tobillo o MTFs. Entesitis, osteítis/hiperostosis, sacroileítis asimétrica (40%). Piel: queratoderma blenorrágico, balanitis, eritema nudoso, lesiones psoriasiformes, pustulosis palmoplantar. GU: uretritis, cervicitis, prostatitis, salpingitis. GI: enteritis o colitis infecciosa o reactiva. Ocular: conjuntivitis, uveítis ant aguda (40%), posterior tb.	LAB HLA B27 + (80%)	En gral es autolimitada. Episodio agudo: - AINEs o corticoides a dosis bajas. Enf persistente (- 20%): - Tto crónico similar al de la AR.				

Miopatías inflamatorias	Baja incidencia: 2-4/100.000 Inicio: 45-60a, y 15a para forma juvenil. + mujeres 2:1 excepto IBM + H 3:1 + raza negra Asoc con HLA DQA1 juveniles HLA DRD1 adultos <u>DD:</u> distrofias, miopatías hereditarias, neurológicas, x fcos y tóxicos, endócrina, inflam. no autoinmunes, infecciosas. <u>Clasificación:</u> <u>EULAR/ACR 2017:</u> • Seguro: >8,7 o >7,5 c/biopsia. • Probable: > 6,7 o >5,5. <u>Bohan y Peter 1975:</u> 1. Debilidad musc prox simét. 2. Miositis en biopsia musc. 3. Enzimas musc elevadas 4. Patrón electromiográfico característico 5. Rash cutáneo característico PM definida: criterios 1-4, probable con 3, y posible con 2. DM definida: criterio 5 + otros 3, probable 5+2, y posible 5+1.	DEBILIDAD → proximal (musculatura de cintura pélvica y escapular) simétrica, progresiva, de 3-6 m de evolución. Tb cuello (grave), tronco. • Aguda → MNIM, DM • Subaguda → DM, OM • Crónica → MCI (IBM), PM Ausencia de compromiso ocular/facial (importante p/DD) Con biopsia: Sin biopsia: <table border="1"> <tr> <td>Edad de inicio de los síntomas</td><td>+ o = 18 y - 40 años</td><td>1,5</td><td>1,3</td></tr> <tr> <td></td><td>+ o = 40 años</td><td>2,2</td><td>2,1</td></tr> <tr> <td rowspan="4">Debilidad muscular</td><td>Debilidad de los músculos de MMSS (simétrica, normalmente progresiva)</td><td>0,7</td><td>0,7</td></tr> <tr> <td>Debilidad de los músculos proximales de los MMII (simétrica, normalmente progresiva)</td><td>0,5</td><td>0,8</td></tr> <tr> <td>Los músculos flexores del cuello son relativamente más débiles que los extensores.</td><td>1,6</td><td>1,9</td></tr> <tr> <td>Los músculos proximales de los MMII son relativamente + débiles que los distales.</td><td>1,2</td><td>1,9</td></tr> <tr> <td rowspan="3">Signos cutáneos</td><td>Eritema en heliotropo</td><td>3,2</td><td>3,1</td></tr> <tr> <td>Pápulas de Gottron</td><td>2,7</td><td>2,1</td></tr> <tr> <td>Signo de Gottron</td><td>3,7</td><td>3,3</td></tr> <tr> <td>Otros smas y signos clínicos</td><td>Tños de la deglución o de la motilidad esofágica.</td><td>0,6</td><td>0,7</td></tr> <tr> <td rowspan="2">Pruebas de laboratorio</td><td>Acs anti-Jo1 (resultado de una prueba realizada con un método estandarizado y aceptado).</td><td>3,8</td><td>3,9</td></tr> <tr> <td>Aum. de la actividad sérica de CK, AST, ALT, LDH (el valor + alto en el transcurso de la enfermedad).</td><td>1,4</td><td>1,3</td></tr> <tr> <td rowspan="4">Biopsia muscular</td><td>Infiltrados de céls mononucleares en el epimisio que rodean a las fibras musculares, sin penetrarlas.</td><td>1,7</td><td>--</td></tr> <tr> <td>Infiltrados de células mononucleares en el perimisio y/o fascículos vasculares (en el perimisio o epimisio).</td><td>1,2</td><td>--</td></tr> <tr> <td>Atrofia perifascicular (las céls q aparecen dispuestas en varias filas alrededor de los fascículos vasculares y nerviosos son visiblemente más pequeñas que las céls de ubicación más central).</td><td>1,2</td><td>--</td></tr> <tr> <td>Vacuolas ribeteadas (se tiñen de azul en tinción hematoxilina-eosina y de rojo en tinción de Gomori modificada).</td><td>3,1</td><td>--</td></tr> </table>	Edad de inicio de los síntomas	+ o = 18 y - 40 años	1,5	1,3		+ o = 40 años	2,2	2,1	Debilidad muscular	Debilidad de los músculos de MMSS (simétrica, normalmente progresiva)	0,7	0,7	Debilidad de los músculos proximales de los MMII (simétrica, normalmente progresiva)	0,5	0,8	Los músculos flexores del cuello son relativamente más débiles que los extensores.	1,6	1,9	Los músculos proximales de los MMII son relativamente + débiles que los distales.	1,2	1,9	Signos cutáneos	Eritema en heliotropo	3,2	3,1	Pápulas de Gottron	2,7	2,1	Signo de Gottron	3,7	3,3	Otros smas y signos clínicos	Tños de la deglución o de la motilidad esofágica.	0,6	0,7	Pruebas de laboratorio	Acs anti-Jo1 (resultado de una prueba realizada con un método estandarizado y aceptado).	3,8	3,9	Aum. de la actividad sérica de CK, AST, ALT, LDH (el valor + alto en el transcurso de la enfermedad).	1,4	1,3	Biopsia muscular	Infiltrados de céls mononucleares en el epimisio que rodean a las fibras musculares, sin penetrarlas.	1,7	--	Infiltrados de células mononucleares en el perimisio y/o fascículos vasculares (en el perimisio o epimisio).	1,2	--	Atrofia perifascicular (las céls q aparecen dispuestas en varias filas alrededor de los fascículos vasculares y nerviosos son visiblemente más pequeñas que las céls de ubicación más central).	1,2	--	Vacuolas ribeteadas (se tiñen de azul en tinción hematoxilina-eosina y de rojo en tinción de Gomori modificada).	3,1	--	EXÁMENES COMPLEMENTARIOS MIOPATÍAS LAB General: • ↑ CPK • Destrucción muscular: ↑ GOT, GPT, LDH • ↑ Aldolasa (Ez + sensible p/dx?) • ↑ leve VES • Anemia de enfermedades crónicas Inmunológico: • ANA (FAN) + (80-90%) → PEDIR SIEMPRE • FR + (50%, a bajo título) • ↑ Acs anti ARN o ags citoplasmáticos (60%) - EJ (DM): ○ Anti Mi2 → lesiones cutáneas. ○ Anti MDA5 → EPI. ○ Anti TIF1 gamma y anti NPX2 → neoplasia en adultos. BIOPSIA MUSCULAR • En casos seleccionados. • A cielo abierto; abarcar piel y nervio. Dermatomiositis: • II >CD4+, perivascular o perifascicular. • IHQ → ↑HLA-1 y depósitos capil. de C5b-9. • Piel: infiltració LB, depósitos de C5b-9 en unión dermoepidérmica. Vasculitis. Polimiositis: • II >CD8+ multifocales, en endomisio. • Fibras de espectro normal. HLA-1. MCI: • Inclusiones citoplasmáticas eosinofílicas. • Vacuolas ribeteadas por gránulos, fibras rojas. HLA-1. MNIM: • Fibras necróticas sin infiltrados. C5b-9. RNM • Confirmar presencia y magnitud del compromiso. • Determinar la distribución. • Selección apropiada de músculo p/biopsia. • Cortes axiales de MM y tronco, en secuencias T11, T2 y STIR. • Alteraciones difusas y multifocales. ELECTROMIOGRAFÍA Y VELOCIDAD DE CONDUCCIÓN NERVIOSA • Solo sirve p/confirmar la presencia de miopatía. • Hallazgos inespecíficos. TAC (tx, abd, pelvis) • En todos los ptes con miositis recién dx, x CA.
Edad de inicio de los síntomas	+ o = 18 y - 40 años	1,5	1,3																																																							
	+ o = 40 años	2,2	2,1																																																							
Debilidad muscular	Debilidad de los músculos de MMSS (simétrica, normalmente progresiva)	0,7	0,7																																																							
	Debilidad de los músculos proximales de los MMII (simétrica, normalmente progresiva)	0,5	0,8																																																							
	Los músculos flexores del cuello son relativamente más débiles que los extensores.	1,6	1,9																																																							
	Los músculos proximales de los MMII son relativamente + débiles que los distales.	1,2	1,9																																																							
Signos cutáneos	Eritema en heliotropo	3,2	3,1																																																							
	Pápulas de Gottron	2,7	2,1																																																							
	Signo de Gottron	3,7	3,3																																																							
Otros smas y signos clínicos	Tños de la deglución o de la motilidad esofágica.	0,6	0,7																																																							
Pruebas de laboratorio	Acs anti-Jo1 (resultado de una prueba realizada con un método estandarizado y aceptado).	3,8	3,9																																																							
	Aum. de la actividad sérica de CK, AST, ALT, LDH (el valor + alto en el transcurso de la enfermedad).	1,4	1,3																																																							
Biopsia muscular	Infiltrados de céls mononucleares en el epimisio que rodean a las fibras musculares, sin penetrarlas.	1,7	--																																																							
	Infiltrados de células mononucleares en el perimisio y/o fascículos vasculares (en el perimisio o epimisio).	1,2	--																																																							
	Atrofia perifascicular (las céls q aparecen dispuestas en varias filas alrededor de los fascículos vasculares y nerviosos son visiblemente más pequeñas que las céls de ubicación más central).	1,2	--																																																							
	Vacuolas ribeteadas (se tiñen de azul en tinción hematoxilina-eosina y de rojo en tinción de Gomori modificada).	3,1	--																																																							
Dermatomio-sitis (DM)		Compromiso cutáneo: • Erupciones roro-violáceas e zonas fotosensibles: - Eritema en heliotropo, pápulas de Gottron (simétricas), signo de Gottron. • Signo de la V, signo del chal (atemporal). • Base uñas: capilares dilatados, telangiectasias, infartos hrr, cutícula "irregular". • Calcinosis cutánea: hasta 50% en juveniles. Compromiso muscular: • Debilidad proximal, dificultad p/caminar, subir escaleras, levantar brazos, etc. • Puede haber dolor. • Rabdomiólisis y falla renal (casos severos). • Disfagia, debilidad parpebral (1/3 de casos). Compromiso articular: • Artritis IF, carpos, codos, cadera, rodilla, tobillos. Compromiso GI: • Alt faringe, 1/3 sup estómago: disfagia → asfixia Compromiso respiratorio: • HTPulm 2ria (poco frec), serositis, EPI. Compromiso cardíaco: • Alts conducción, arritmias, disnea, miocardiopatías, pericarditis, serositis. LAB • ↑ CPK x 10-50 veces • Acs: - Anti Mi-2 (20%) - Anti MDAS (10-30%) - Anti TIF-1 gamma → 75% asoc a tumores malignos en adultos. - Anti NXP 2 - Anti SAE (8%) RX • Compromiso articular: estrechez del espacio articular y erosiones óseas. Endoscopia y estudios deglutorios • Ante disfagia/asfixia Pruebas de función pulmonar, TAC tx ECG, ECO cardíacos																																																								

Dermatiomiositis amniopática	Asociada a + riesgo de cáncer.	El 20% de las DM que solo tienen manif. CUTÁNEAS. No hay debilidad muscular. Enf. pulmonar intersticial → grave.	LAB • CPK sérica normal. • Acs + frec: Anti SAE y MDA5.	TRATAMIENTO MIOPATÍAS FARMACOLÓGICO (se empieza con corticoides + MTX/otra en simultáneo) • Corticoides - Inducción: ○ Metilprednisona bolos EV de 200-1000mg/d x 3-5d, o prednisona-meprednisona VO 0,5-1mg/kg/d. ○ Mantener hasta mejoría de la fuerza muscular y ↓ CPK. ○ Continuar x 4-12 sem. - Mantenimiento: ○ ↓ 10 mg c/1-2 sem hasta alcanzar los 20 mg/d. • Inmunosupresores ahorradores de esteroides (si el tto con corticoides no funciona). P/mantenim. - Gammaglobulina EV → 1-2g/K/ciclo de tto c/3-6 sem, x 1-3d con dosis de 0,5-1 g/kg/d. ○ Eficaz en IMNM x HMGCR, y p/↓ disfagia en MCI. - Ciclofosfamida - Rituximab → 1 gr, repetir a las 2 sem y eval rta a los 6 meses. ○ Efectivo en casos refractarios. - Hidroxicloroquina - Azatioprina → 50mg/d x 1sem y dp ↑ c/sem hasta 200 mg/d y más. - Micofenolato - MTX → 1x/sem dosis de 5-20 mg + 5mg de ác. fólico al día siguiente. ○ Ojo CI, sobre todo pulmonar. • Tto experimental para MCI: alemtuzumab, folistatina. • Compromiso vasculítico o pulmonar: pulsos de corticoides + ciclofosfamida o rituximab. NO FARMACOLÓGICO • Rehabilitación precoz → previene nuevos focos de necrosis. • Ejercicios de resistencia de forma gradual.																	
Miopatía por cuerpos de inclusión (IBM)	No es una miopatía inflamatoria en sí, en la biopsia no hay inflamación. + en hombres de >50 años. Compromiso proximal y DISTAL. No tiene tto. Se puede alargar la expectativa de vida con rehabilitación.	Atrofia de flexores largos de dedos a nivel del antebrazo y cuádriceps. Inicio <i>asimétrico</i> y puede que unilateral de 1 pierna o brazo Progresión lenta y continua (años) → grave atrofia muscular → 1° sma: caídas. Sin compromiso cutáneo. La disfagia es frecuente.	LAB • ↑ CPK leve (x 10-15 veces). • Ac Anti cN1A (30-60%).																		
Polimiositis (PM)	Forma + rara de miositis (5%). Que sea una patología en sí es relativo. Dx de exclusión.																				
Miopatía necrotizante inmuno-mediada (MNIM)	Hasta 19% de las MI. Más en adultos. Evolución + rápida y grave que la DM. (Hay 5 subtipos).	Miositis de inicio agudo y severo, con máxima expresión en días/semanas. Sme paraneopásico (descartar CA)	LAB • CPK muy elevada (> 50 x) • Ac antiSRP y HMGCR ↑(60%)																		
Smes de superposición asociados a miositis (OM)	Dx en conjunto con otras enf del TC. + común: Sme Antisintetasa (ASS)	Inicio agudo/subagudo de debilidad de brazos y piernas. Manif. Asociadas: artritis, EPI, Raynaud, lesiones cutáneas de LES, etc. SAS: • Enf pulmonar intersticial - Entre 79 y 95% de los casos. - En el 50% precede a la miositis. - Asintomáticos, tos seca, disnea, crepitantes velcro bibasales, etc. - Tipos: neumonía intersticial no específica, usual, aguda, organizada. • Sme de Raynaud • Fiebre • Poliartritis distal simétrica de manos y pies • Rash cutáneo (indistinguible de la DM) • “Manos de mecánico” - Lesiones hiperqueratósicas escamosas, simétricas, no pruriginosas. Tb en pies.	LAB • ↑Ezs musculares (CPK x 10-50 veces) Acs: <table><tr><th>Asociados</th><th>Específicos SAS</th></tr><tr><td>Anti-PM/Scl (ES)</td><td>Anti Jo1</td></tr><tr><td>Anti U1RNP (EMTC)</td><td>Anti PL7</td></tr><tr><td>Anti-Ro52 (SS, LES, ES)</td><td>Anti PL12</td></tr><tr><td>Anti-Ku (EMTC, ES, LES)</td><td>Anti EJ</td></tr><tr><td></td><td>Anti OJ</td></tr><tr><td></td><td>Anti Ha</td></tr><tr><td></td><td>Anti KS</td></tr><tr><td></td><td>Anti Zo</td></tr></table> TC • Para EPI - Vidrio esmerilado - Consolidación perif. basal - Engrosamiento septal - Panal de abejas		Asociados	Específicos SAS	Anti-PM/Scl (ES)	Anti Jo1	Anti U1RNP (EMTC)	Anti PL7	Anti-Ro52 (SS, LES, ES)	Anti PL12	Anti-Ku (EMTC, ES, LES)	Anti EJ		Anti OJ		Anti Ha		Anti KS	
Asociados	Específicos SAS																				
Anti-PM/Scl (ES)	Anti Jo1																				
Anti U1RNP (EMTC)	Anti PL7																				
Anti-Ro52 (SS, LES, ES)	Anti PL12																				
Anti-Ku (EMTC, ES, LES)	Anti EJ																				
	Anti OJ																				
	Anti Ha																				
	Anti KS																				
	Anti Zo																				
Miopatías inducidas x fármacos	Agentes: • Estatinas (dosis dependiente) → pedir CPK previa a su indicación. • Fibratos (solos o combinados). • Corticoides → lenta progresión, no doloroso, ezs normales. Biopsia característica (atrofia sin degeneración ni regeneración). <i>Único que deja secuelas al suspender, si ya hizo daño.</i> • Colchicina (polineuropatía, CPK alta) → biopsia con miopatía vacuolar sin necrosis. • Antipalúdicos (independiente de dosis y duración). • Otros: D-penicilamina, hidroxiurea, AZT, ciclosporina A, alcohol, L-triptofano (suplemento)... No hay compromiso cutáneo. Suele dar dolor muscular junto con la debilidad.																				

LES (y enf. asociadas)	Enf. inmune inflamatoria sistémica, con supresión de LT e hiperproliferación LB. + mujer 9:1. Incidencia: 4-7/100.000. Preval: 15-50 c/100.000. Raza: negros → asiáticos → blancos. Sobrevida a 10 años: 90%, y 20 a, 70%. Etiología: Multifactorial: factores genéticos y ambientales. Criterios ACR/EULAR 2019:																								
	<table><tr><th>Manifestaciones clínicas</th><th>Puntos</th></tr><tr><td>Manifestaciones constitucionales Fiebre</td><td>2</td></tr><tr><td>Manifestaciones cutáneas Alopecia Úlceras orales Lupus cutáneo subagudo o lupus discoide Lupus cutáneo agudo</td><td>2 2 4 6</td></tr><tr><td>Manifestaciones articulares Sinovitis o dolor en al menos 2 articulaciones</td><td>6</td></tr><tr><td>Manifestaciones neuropsiquiátricas Delirios Psicosis Convulsiones</td><td>2 3 5</td></tr><tr><td>Serositis Derrame pleural o pericárdico Pericarditis aguda</td><td>5 6</td></tr><tr><td>Manifestaciones hematológicas Leucopenia Thrombocitopenia Hemólisis autoinmune</td><td>3 4 4</td></tr><tr><td>Manifestaciones renales Proteinuria >0,5 g/24h Class II o V nefritis lúpica Class III o IV nefritis lúpica</td><td>4 8 10</td></tr><tr><td>Parámetros inmunológicos</td><td>Puntos</td></tr><tr><td>Anticuerpos antifosfolípidos Anticardiolipin IgG > 40 GPL o anti-β2GP1 IgG > 40 unidades o lupus anticoagulant</td><td>2</td></tr><tr><td>Complemento C3 o C4 bajo C3 y C4 bajo</td><td>3 4</td></tr><tr><td>Anticuerpos altamente específicos Anti-dsDNA anticuerpos Anti-Sm anticuerpos</td><td>6 6</td></tr></table>	Manifestaciones clínicas	Puntos	Manifestaciones constitucionales Fiebre	2	Manifestaciones cutáneas Alopecia Úlceras orales Lupus cutáneo subagudo o lupus discoide Lupus cutáneo agudo	2 2 4 6	Manifestaciones articulares Sinovitis o dolor en al menos 2 articulaciones	6	Manifestaciones neuropsiquiátricas Delirios Psicosis Convulsiones	2 3 5	Serositis Derrame pleural o pericárdico Pericarditis aguda	5 6	Manifestaciones hematológicas Leucopenia Thrombocitopenia Hemólisis autoinmune	3 4 4	Manifestaciones renales Proteinuria >0,5 g/24h Class II o V nefritis lúpica Class III o IV nefritis lúpica	4 8 10	Parámetros inmunológicos	Puntos	Anticuerpos antifosfolípidos Anticardiolipin IgG > 40 GPL o anti-β2GP1 IgG > 40 unidades o lupus anticoagulant	2	Complemento C3 o C4 bajo C3 y C4 bajo	3 4	Anticuerpos altamente específicos Anti-dsDNA anticuerpos Anti-Sm anticuerpos	6 6
	Manifestaciones clínicas	Puntos																							
	Manifestaciones constitucionales Fiebre	2																							
	Manifestaciones cutáneas Alopecia Úlceras orales Lupus cutáneo subagudo o lupus discoide Lupus cutáneo agudo	2 2 4 6																							
	Manifestaciones articulares Sinovitis o dolor en al menos 2 articulaciones	6																							
	Manifestaciones neuropsiquiátricas Delirios Psicosis Convulsiones	2 3 5																							
	Serositis Derrame pleural o pericárdico Pericarditis aguda	5 6																							
	Manifestaciones hematológicas Leucopenia Thrombocitopenia Hemólisis autoinmune	3 4 4																							
	Manifestaciones renales Proteinuria >0,5 g/24h Class II o V nefritis lúpica Class III o IV nefritis lúpica	4 8 10																							
Parámetros inmunológicos	Puntos																								
Anticuerpos antifosfolípidos Anticardiolipin IgG > 40 GPL o anti-β2GP1 IgG > 40 unidades o lupus anticoagulant	2																								
Complemento C3 o C4 bajo C3 y C4 bajo	3 4																								
Anticuerpos altamente específicos Anti-dsDNA anticuerpos Anti-Sm anticuerpos	6 6																								
REFERENCIA: Aringer et al. Abstract #2928. 2018 ACR/ARHP Annual Meeting																									
✓ Los criterios de clasificación no son criterios de diagnóstico. (son acumulables)																									
✓ Todos los pacientes deben tener ANA ≥ 1:80 (criterio de entrada)																									
✓ Los pacientes deben tener ≥ 10 puntos para ser clasificados como LES																									
✓ Los puntos solo se pueden contar si no hay una causa más probable																									
✓ Solo cuenta el criterio más alto en una categoría dada																									
✓ La clasificación de SLE requiere puntos de al menos un dominio clínico																									

<u>Manifestaciones generales</u> (80%): - Astenia, fatiga, pérdida de peso, fiebre (FOD). <u>Manifestaciones cutáneas:</u> Específicas: Agudas (no dejan cicatriz. Por IC): - Rash malar, eritema generalizado, lesiones bullosas, fotosensibilidad. Subagudas (no dejan cicatriz. Por IC): Lesiones anulares policíclicas (SOLO LES). - Placas psoriasiformes (+ en V del cuello). Crónicas (dejan cicatriz. Por LT): - Rash discoide, lupus profundo (inflam TCS) No específicas: - Paniculitis, alopecia, úlceras orales o genitales, lesiones urticarianas, Raynaud, lesiones vasculíticas, perforación tabique nasal. <u>Manifestaciones musculoesqueléticas:</u> - Artritis - Forma de presentación + común. + frec manos y rodillas, poliartritis (DD AR) simétrica, no erosiva, desviación cubital al inicio (en AR es cdo está avanzada). - Osteonecrosis - X uso crónico corticoide (obesos ↑ riesgo) + frec en caderas/rodillas, dolor agudo limitante (es un infarto óseo) → DX: RMN. <u>Manifestaciones renales:</u> - Alts lab, edemas, HTA. - Predictores de nefropatía → embarazo, hombre, linfopenia, C3 bajo, Anti-ADN nativo +. - Glomerulopatías (smas con la enf. avanzada). <u>Manifestaciones neuropsiquiátricas:</u> Disfunción cognitiva, cefaleas refractarias, convulsiones, ACV (x vasculitis o SAF), psicosis, depresión, mielitis (x SAF). <u>Serositis:</u> Derrame pleural (30-60%), drr pericárdico. <u>Manifestaciones hemodinámicas:</u> - Anemia autoinmune hemolítica, leucopenia (es frec la linfopenia aislada), trombocitopenia, hipocomplementemia (+ C4), etc. Patrón de mortalidad bimodal: Temprana → x enf. no controlada. - Compromiso renal, neuro, infecciones. Tardía → x complicaciones crónicas. - Diálisis, toxicidad de drogas, aterosclerosis (↑ riesgo IAM).
--

LAB
BUSCAR ENF. RENAL:
Análisis de orina simple y sedimento urinario: - Cilindros granulosos - Proteinuria - Hematuria microscópica - Piuria sin infección
Anticuerpos: ANA (FAN) → solo p/dx. Anti-ADN → asoc con compromiso renal y neurológico. Anti-Ro (SS-A), Anti-La (SS-B) → sirven ante ANA -. Frec. en lupus neonatal y compromiso cutáneo. Asoc a sme de Sjögren. Asoc – con GNF. Anti-SM (Smith) → asoc – con Sjögren. Muy específico de LES. Anti-RNP → asoc a Raynaud, linfadenopatías, enf mixta TC Acs antifosfolípidos → VDRL +, asoc con SAF.
HISTOPATOLOGÍA
Daño renal: - Clase 1: normal. - Clase 2: GN mesangial pura. - Clase 3: GN prolif. Focal y segmentaria. Clase 4: GN prolif. difusa: + grave y frec. - Clase 5: GN membran. - Clase 6: esclerosis glomérulo Para “cubrir” al pte x el mes: 1ºd → pulso corticoides. 2ºd → pulso corticoides. 3ºd → pulso corticoides + ciclofosfamida. Lo que se suele hacer es 6m de ciclofosfamida, y el mantenimiento con azatioprina.

BÁSICO: (4 pilares: no puede faltar a nadie. De x vida) Educación AINEs (a demanda) - EJ: naproxeno, diclofenac. Ibuprofeno CI. Indometacina ↑ lesiones piel, no usar COX2 selectivos cdo hay SAF asociado. - Como ahorradores de corticoides. Corticoides - Piedra angular del tto. Prednisona (dosis depende de manif. Clínica): Dosis baja: < 10 mg/d. Dosis media: 10-40 mg/d. Dosis alta: > 40 mg/d. Pulsos: 500-1000 mg/d. - Descenso lento hasta dosis mín aceptable. - EA x uso crónico/pulsos: úlceras, necr. ósea, miopatías, psicosis. Antipalúdicos (hidroxicloroquina) - Ahorrador de corticoides. - Muy bueno p/control de smas grales. ↓ frec. de brotes. - Es hipolipemiente y antitrombótico. - Rta clínica a las 4-6 sem. - EA: toxicidad ocular, GI, neuropatías, etc.
SMAS CONSTITUCIONALES: AINEs, corticoides dosis bajas, evaluar antidepresivos.
MANIFESTACIONES CUTÁNEAS: - Evitar luz UV/pantalla solar (siempre SPF >40). - Corticoides dosis bajas, antipalúdicos, dapsona (bueno p/LES cutáneo subag), biológicos, etc.
ARTRITIS: - AINEs, corticoides dosis bajas, antipalúdicos, MTX. - Si hay falta de rta → Belimumab.
COMPROMISO NEUROPSIQUIÁTRICO: Pulso corticoides + ciclofosfamida (símil nefrop G4).
COMPROMISO HEMATOLÓGICO: (ante clínica significativa) Corticoides altas dosis, filgastrin, belimumab.
COMPROMISO RENAL:
GNF II Corticoides dosis intermedias (10-40 mg de inicio).
GNF III – IV – V
Inducción (6 meses): Pulsos de corticoides (1g/d x 3d, internado). Pulsos de ciclofosfamida (0,75-1g/mes, en 6 infusiones).
Mantenimiento (hasta 2 años): Ciclofosfamida → en infusión mensual x 6 m, y dp trimestral x 1 año. Azatioprina 2-3 mg/k/d. - Mofetil micofenolato 1-3 gr/d (muy efectiva pero cara y con + EA).

Sme de Sjögren	Enf. autoinmune que compromete ppalmente glánds. exócrinas (salivales, lagrimales, páncreas, Gl, sudor). Presentación: - Solo (1rio) - Asociado a LES (2rio) Aparece + tarde que LES (40-50 años).	Síntomas SICCA (sme seco): xerostomía, xeroftalmia, sequedad vaginal, estreñimiento, etc. Artralgias. Compromiso renal (acidosis tubular renal). Compromiso neurológico (polineuropatías).	LAB - ANA + - Anti Ro y Anti La + (los 2)	
SAF	Enf. x tno de la coagulación x determinados acs, +: Abortos recurrentes (pérdida emb. < 12 sem sin otra causa, perder Acs SAF). - TVP, TEP. - Trombosis arteriales agudas (ACV, infarto pulmonar, mesentérico, cardíaco, necr ósea, etc).		LAB Acs antifosfolipídicos	
Lupus neonatal		Bloqueo AV congénito (grave y asintomático: ↑ muerte). Lesiones símil LCSA (desaparecen dentro de los 6 meses)	LAB Ro + en la madre	Las lesiones símil LCSA no se tratan. Seguimiento: ecocardio fetal entre las 18-32 sem. Profilaxis: dexametasona (p/"limpiar" a la mamá del Ac).
Lupus x drogas	<u>Agentes:</u> carbamazepina, isoniacina, fenitoína , metildopa, procainamida, hidralazina, clorpropamina, quinidina, minociclina, sulfasalazina...	Clínica similar a LES (↑ manif. Cutáneas y pulmonares). Cuadro remite al suspender la droga (puede llevar hasta 1 año).	LAB - ANA + - Auto Acs – - Antihistonas +	
Vasculitis	Enfermedades caracterizadas x II y necrosis sobre la pared de los vasos sanguíneos. Clasificación: <u>Grandes vasos:</u> - Arteritis de Takayasu - Arteritis de céls gigantes <u>Medianos vasos:</u> - Poliarteritis nodosa - Enf. de Kawasaki <u>Pequeños vasos (asoc. con ANCA):</u> - Poliangitis microscópica - Granulomatosis con poliangitis (Wegener) - Granulomatosis eosinofílica con poliangitis (Churg Strauss) <u>Pequeños vasos (inmunocomplejos):</u> - Vasculitis x IgA (púrpura de Henoch-Schönlein) - Vasculitis crioglobulinémica - Vasculitis urticarial - Enf. anti-MBG <u>Vasos variables:</u> - Enf. de Behcet - Enf. de Cogan <u>Otras:</u> - Vasculitis x drogas - Vasculitis x enf sistémica	Smas gales: Fiebre (sme febril prolongado) - Fatiga - Pérdida de peso - Artralgias Smas específicos: - Escleritis (historia de inflam ocular). - Wegener → costras nasales, epistaxis, enf VAS. - Takayasu, GCA → oclusión arterial (claudicación de extremidades). - Hrr alveolar (hemoptisis inexplicable). - Sme pulmón-riñón (hrr pulm + insuf renal). Mononeuritis múltiple → hipo/disestesias, debilidad motora de extremidades. - Púrpura palpable (vitropresión –). Úlceras cutáneas. - Pulsos ↓ o ausentes → palpar pulsos, auscultar soplos (carótida, subclavia, femoral, Ao, etc).	LAB <u>General:</u> - Hemograma completo - Creatinina sérica - Función hepática - VSG y/o PCR - Serologías p/hepatitis viral, crioglobulinas séricas - Análisis de orina + sedimento urinario - Hemocultivos (en sme febril, p/descartar endocarditis) <u>Específico:</u> - ANA/FAN - Complemento - ANCA Otros estudios (guiarse x clínica): <u>RX o TC tx</u> - En ptes con smas resp. <u>ELECTROMIOGRAFÍA</u> - Ante smas de enf neuromuscular <u>PUNCIÓN LUMBAR/IMÁGENES SNC</u> - Ante smas sugestivos de vasculitis 1ria del SNC. <u>BIOPSIA</u> - Según región afectada. <u>ANGIO-RM</u> <u>ANGIO-TAC</u> <u>ECO Doppler vascular</u> A. temporal: halo hipocóico <u>PET</u>	<u>Smas cutáneos:</u> Corticoides a bajas dosis. - Hidroxicloroquina. - MTX. - Colchicina. <u>Smas generales:</u> Corticoides a dosis moderadas. <u>Smas viscerales:</u> <u>Inducción:</u> Corticoides dosis altas + ciclofosfamida. (EJ: prednisona) - En la enf de Churg Strauss no se usa ciclofosfamida de entrada. - Gammaglobulinas en casos refractarios. - Plasmáféresis. - Rituximab. <u>Mantenimiento:</u> - Azatioprina. - MTX.

Arteritis de Takayasu	Afecta a Ao y ramas ppales. Sitio + común: subclavias. Afectación sectorial o panaortitis. Ppal factor pronóstico: HTA. Edad media de inicio: 25 años. Mayor prevalencia en Asia. + en mujeres 9:1 20% asintomáticos al dx. No suele comprometer MMII.	Criterios dx (al menos 3 de 6): Inicio < 40 años. Claudicación de una extremidad. ↓ pulso braquial. Dif de P sistólica > 10 mmHg entre brazos. Soplos sobre as. Subclavias y/o Ao. Evidencia radiológica de estenosis u oclusión de Ao y ramas ppales. Cianosis y/o dolor en miembros (claudicación). Smas constitucionales inespecíficos. Carotidinia (dolor y sensibilidad arterial) → dolor cervical unilateral. EF: medición TA, palpación pulsos, identificación soplos, auscultación cardíaca. Dx: clínica + imágenes (no biopsia)	Polimialgia reumática: - Dolor y debilidad proximal de inicio súbito en cuello, cintura escapular y pelviana (- frec). - Limitación en rango de movimiento. - Sinovitis distal (muñecas, MCF). - Asoc a anemia y VSG elevada. - FR y Anti-CCP – . > 60 años en el 95% de los casos. - Remite con bajas dosis de corticoides (10-20mg) en aprox 18 meses.
Arteritis de células gigantes (GCA)	Panarteritis medianos/grandes vasos + sme de rta inflamatoria sistémica. “Arteritis de la temporal”. Afecta a Ao y ramas ppales, > ramas de carótida, a. temporal superficial. Edad media: 68 años (siempre > 50). + mujeres 4:1	30% asociada a polimialgia reumática. Smas constitucionales. Cefalea bitemporal de reciente inicio. Hipersensibilidad en cuero cabelludo. Arteria temporal palpable. Claudicación mandibular. Amaurosis fugaz, ceguera. Dx: biopsia	
Poliarteritis nodosa (PAN)	Respeta capilares y vénulas. Afecta cualquier órgano excepto pulmón. Afectación segmentaria. Edad media: 48 años. + hombres 1,3:1 Mayoría idiopáticos. Puede ser 2ria a → hepatitis (VHB, VHC), HIV, TBC, leucemia, linfoma, etc.	<u>Manif cutáneas:</u> - Púrpura palpable, nódulos, infartos digitales, úlceras, gangrena, lúcido reticularis. <u>Manif. Sistema nervioso:</u> - Mononeuritis múltiple (asimétrica→simétrica)... - Central (<10%): encefalopatías, ACV, hrr, convul. <u>Manif renales:</u> GNF Pauci-inmune → hematuria, HTA, hematoma perirrenal. <u>Manif GU:</u> - Dolor testicular y epidídimo, estenosis uretral. <u>Manif GI:</u> - Dolor abd (x arteritis mesentérica), infartos intestinales, hrr digestiva baja. <u>Manif musculoesqueléticas:</u> - Poliartralgias/itis sistémicas de grandes artic. <u>Manif cardíacas:</u> - HTA, ↑FC, frote pericárdico, IC congestive, arrit. <u>Manif oftalmológicas:</u> - Vasculitis retiniana, desprendimiento de retina, exudados algodonosos.	LAB - Anemia crónica simple - VSG ↑ - Leucocitosis neutrofílica - Trombocitosis - Complemento N - HBsAg 10% / VHC / ANCAp BIOPSIA – IMÁGENES <u>Etapas aguda:</u> - II poliformonuc en todas las capas de la pared vascular. <u>Etapas subaguda:</u> ↑ II de mononucleares. <u>Etapas crónica:</u> - Necrosis fibrinoide (causa trombosis e infarto tisular). - Dilataciones aneurismáticas. Lesiones renales: - Arteritis sin GNF.
Poliangeítis microscópica (PAM)	Afecta arteriolas, capilares y vénulas. Diferencias PAM vs PAN: - Compromiso neurol. raro. - El daño es x depósito de inmunocomplejos. - Sin cambios angiográficos. - No se asocia a HBV. - ANCAp 80-90%.	Pródromos hasta 2 años antes. 20% tiene debut renal fulminante (GNRP). EPI → tos seca, disnea, hemoptisis, hrr alveolar... Sme pulmón-riñón (causa + frec) → P anca MPO → necrotizante no granulomatosa → GN pauciinmune → HAD.	LAB 90% ANCAp - MPO BIOPSIA - Ausencia de granulomas. - Vasculitis necrotizante.

Granulomatosis con poliangitis (Wegener)	Enf. necrotizante y granulomatosa. Edad media: 45 años. Presentación + frec: • VAS • Artromialgias • Smas gales	90% tiene afectación nasal, sinusal u oído (en PAM 35%): • Costras nasales, dolor senos/rinosinusitis crón., compromiso laríngeo, úlceras en tabique nasal, nariz en silla de montar, obstrucción, alts olor, secreciones nasales, mucocoeles. • Hipoacusia, otitis media. <u>Smas oftalmológicos</u>: epífora, escleritis, uveítis, proptosis. <u>Smas pulmonares</u>: estenosis subglótica, estenosis y ulceración bronquial, nódulos pulmonares, EPI, hrr alveolar. <u>Smas renales</u>: hematuria, ↑ creatinina sérica, GNRP. <u>Smas nerviosos</u>: mononeuritis múltiple, tinnitus, hipoacusia <u>Smas musculoesq</u>: artralgias simétricas de manos, mialgias. <u>Piel</u>: lesiones vasculares purpúricas y hrr, nódulos SC. <u>Corazón</u>: pericarditis, miocarditis, anomalías conducción.	LAB • 80-90% ANCAc – PR3 • ↑ creatinina sérica + hematuria y cilindros celulares, proteinuria.	
Granulomatosis eosinofílica con poliangitis (sme de Churg-Strauss)	Edad media: 40 años. “Siempre pulmón, poco riñón”. Fases: PRODRÓMICA: rinitis, ASMA del adulto. EOSINOFÍLICA: eosinofilia en S y órganos VASCULÍTICA: vasculitis sistémica, smas constitucionales (PP, fiebre, astenia...).	<u>Manif pulmonares</u> → asma, drr pleural, nódulos, opacidades con eosinofilia. <u>Manif otorrino</u>. → rinitis alérgica, otitis, sinusitis, pólipos. <u>Piel</u> → nódulos SC, púrpura palpable MMII, úlceras. <u>Corazón</u> → IC, alts del ritmo, pericarditis. <u>SNC</u> → mononeuritis múltiple, hrr cerebral, infarto cerebral, parálisis ns craneales, pérdida agudeza visual. <u>Riñón</u> → hematuria, proteinuria, GN necrotizante. <u>GI</u> → gastritis eosinofílica (dolor abd, drr, sangrado, colitis). <u>Musculoesq</u> → mialgias, artralgias, miositis, artritis.	LAB • ANCAp 40-50%. • Eosinofilia en S perif. BIOPSIA • II pulmonares migratrices.	Criterios dx (4 criterios → S 85%, E → 99,5%): • Historia de asma. • Eosinofilia > 10%. • Mononeuritis o polineuritis. • II pulmonares migratrices. • Alts en senos paranasales. • Biopsia con acumulación de Eo extravasculares.
Osteoporosis	Enf. producida x el desbalance entre formación y resorción ósea. En 50-60% de mujeres postmenopáusic. FR: • Hipoestrogenismo • Menopausia precoz • TBQ • Sedentarismo • ↓ ingesta Ca • Déficit vitD • Raza blanca • BMI <21 • Fármacos (corticoides, anticoagul., anticonvulsivos, diuréticos, IBP, levotiroxina a dosis supresiva, ISRS...) • Enf. asociadas Pico masa ósea: 30 años → 1-2% de pérdida anual, y 4-7% post menopausia. T score de la DMO: • +1 → -1 densidad normal. • -1 → -2,5 osteopenia. • -2,5 osteoporosis.	ASINTOMÁTICO Dolor dorsal (x microfracturas vertebrales), pérdida de estatura (x vértebras que se achican), fracturas, deformidades. Indicaciones: • Mujer >65 años / Hombre >70 años. • Mujer postmenopáusica + FR • Enf asociadas luego del año del dx (endocrinopatías: DBT, Cushing, hipertiroidismo, hiperPRL, hipercalciuria, etc). • Uso de fcos de riesgo x >6 meses.	DMO Sitios a medir (ideal: 2 regiones): • Raquis lumbar • Cuello femoral lado no hábil • Excepción: radio ultradistal Sitios NO indicados: • Triángulo de Wads • Trocáner • DMO de cuerpo entero Consideraciones con columna lumbar: • Usar L1-L4. • Evaluar vértebra x vértebra. • Descartar mediciones q se alejen 1 DE del cuerpo vertebral adyacente. • Usar al menos 2 vértebras contiguas para el dx. Consideraciones con cadera: • Usar cuello femoral o fémur proximal para el dx. • No utilizar el promedio. • Solicitar cadera – hábil. • Si hay escoliosis, solicitar ambas caderas. LAB (metab fosfocálcico antes del tto) • Ca, P, vitD, FAL, PTH, TSH, calciuria 24hs, B cross laps.	Tto basal: • Dieta rica en Ca, exposición solar, ejercicio, no TBQ, mantener BMI 24-28, Ca 1500 mg/d, vitD 400-800 U/d Osteopenia: • Asegurar Ca y VitD. • NO DAR BIFOSFONATOS. Osteoporosis: • Terapia hormonal de reemplazo (THR) - En 1ros 2 años postmenopausia. - Tibolona y raloxifeno. • Bifosfonatos (1° elección) - Tiempo máximo: 5 años. - En ayunas, con 2 vasos de agua, no comer ni acostarse x 1hr. - Alendronato 70 mg/sem VO. - Risedronato 150 mg/mes VO. - Pamidronato 90 mg c/3 meses EV. - Ibandronato 150 mg/mes VO y EV. - Zolendronato 5 mg/año EV (hay que internarlo). • Si hay falla a bifosfonatos o tiempo máximo: (x 2 años, se puede rotar o volver a bifosfonatos) - Calcitonina → spray nasal, 2x/d. - Análogos de la PTH (teriparatide) → SC. - Ranelato de estroncio - Denosumab → SC c/6 m (tipo vacuna). - Romosozumab → SC c/mes.

Artrosis (osteoartritis)	Disbalance entre degradación y síntesis del cartílago articular, la MEC y el hueso subcondral. Enf. articular + frec. Incidencia ↑ con la edad. Clasificación: 1ria (idiopática, x desgaste) - Artic. Periféricas (MTF, rodillas, caderas, NO carpos). - Columna. 2ria (+ precoz que la 1ria) - Trauma, artropatía, enf. endocrinometabólica, artritis crística, artic. de Charcot, displasias óseas, etc. FR: - Forma generalizada: - Edad, historia fliar, obesidad (↑ carga). - Forma localizada: - Inestabil. Articular, hiperlaxitud, trauma, incongruencia articular, reducción de activ. Propioceptiva. Historia natural de la osteoartritis: - Pérdida progresiva cartílago. - Crecimiento subcondral. - Osteofitos marginales.	Síntomas ("mecánicos"): Dolor articular con el MOVIMIENTO. Rigidez y deformidad articular. Limitación de los movimientos. - Sensación de inestabilidad (> cadera, rodillas). - Alt. Progresiva de la marcha/actividades diarias. Signos: - Limitación del movimiento articular. Tumefacción articular, ↑ tamaño, dura. (Artrosis inflamatoria: puede ser blanda) - Áreas dolorosas periarticulares. - Crepitación articular.	LAB Hemograma: solo p/exclusión. Líquido sinovial: no inflamatorio. RX Hallazgos: - Pinzamiento articular asimétrico. - quistes subcondrales. Esclerosis del hueso subcondral (el reborde se pone blanco). Osteofitos (prolif. Ósea). - Trastornos de alineación. ECO - Inflam. sinovial. - No muestra edema óseo. - No ayuda mucho. RMN - Volumen del cartílago (se puede medir el grosor). - Edema óseo.	"Es como las canas. Paciente que no le duele, no se trata". NO FARMACOLÓGICO - Educación, pérdida de peso. - Ejercicios sin carga (pilates, yoga, aquagym...). FARMACOLÓGICO Analgésicos (paracetamol) 1° línea. Dosis: 1gr c/6-8hs (máximo 4gr/d). - Solo tto sintomático: alivio del dolor. AINES - En dolor mod/severo, OA inflamatoria. - Usar menor dosis por menor tiempo posible. Opiáceos (tramadol (+ usado), codeína, oxicodona, etc) - Ptes no cx con dolor a pesar del uso de AINES. Capsaicina tópica - Muy efectiva, pero dura 3-5hs. - p/tto de dolor leve monoarticular. Colchicina Corticoides intraarticulares - Uso en OA inflamatoria. No usar >2 veces/año. Drogas modif de la enf OA (DMOAD): Condroitinsulfato → componente MEC (GAG). P/grandes artic. 1200 mg/d. Glucosamina → estimula regeneración cartílago. P/grandes artic. 1500 mg/d. Ácido hialurónico → GAG. Dar semana/mensual IV. Diacereína → P/pequeñas artic. 50-100 mg/d. Insaponificables de palta y soja → P/pequeñas artic. 300 mg/d (100 de palta y 200 de soja). No tiene EA. QUIRÚRGICO (si siguen con smas/discapacidad pd >6m) - Artroscopía (+ sencilla), osteomía, prótesis (tto definitivo, óptimo 65-75 años), fusión articular (si hay CI prótesis), implante de condrocitos.
Esclerodermia	Enf. crónica autoinmune. + mujeres 4:1. Aparición: 30-50 años. Etiología: multifactorial. 3 niveles: Afectación vascular → pérdida regul. Tamaño capilares frente al frío. Cambios inflamatorios → hay ↑ prod. colágeno y fibrosis. Alteración autoinmune → auto Acs pq el cuerpo percibe el nuevo colágeno como extraño. Tipos: Localizada (morfea en placa, lineal, en golpe de sable) Sistémica limitada (dedos, rostro, V del cuello) Sistémica difusa (toda la piel)	Fase temprana: Fenómeno de Raynaud → SMA CAPITAL. Todo el que lo tenga debe estudiarse esclerodermia. Edema (duro) y prurito de manos. Rigidez matinal. Fase tardía: Esclerosis cutánea con úlceras digitales ("en mordedura de rata"), infecciones y gangrena. Cambios faciales (afinamiento nariz, acortamiento labio sup, afinamiento pómulos). - Borramiento de arrugas de las manos. Fibrosis pulmonar (EPI), HTPulm → <i>pronóstico</i>. Se empieza a desarrollo antes q smas aparezcan. - Problemas para deglución, malabsorción, PP. - Taquicardias, arritmias, bloqueos de rama. - Crisis renal esclerodérmica (rara, muy grave).	Estudios de la fase temprana (a todo pte q consulta x Raynaud x 1ra vez): ANA Capilaroscopia Una vez al año, hacer: LAB - De rutina - Acs ANA - Acs anti-centrómero - Acs anti SCL 70 SEGD TAC de tx alta resolución ECO Doppler cardíaco	No hay tto 100% efectivo. Antifibróticos cutáneos: Glucocorticoides (fase temprana) + ahorrador (MTX). MTX (no en compromiso pulmonar). - D-penicilamina. - Micofenolato mofetil. Tnos vasculares (Raynaud): - Bloqueantes cálcicos (nifedipina, diltiazem) - Nif: 10-30 mg/d. Da hTA así que dar de noche. Cilostazol + nifedipina (vasodilat. de pequeños vasos). - Sildenafil (p/HTPulm, problemas vasculares). - Bosetan EPI: - Manejo con el neumonólogo. HTPulmomar: - Manejo con el cardiólogo.

Gota	Enf. x depósito de urato monosódico en artíc, tejido blando periartíc, y riñones, x ↑ sostenido de ácido úrico en plasma. Etiopatogenia: PREDISPOSICIÓN + HIPERURICEMIA + TIEMPO ↓ DEPÓSITO TISULAR DE URATO - Interacción cristales con céls de la sinovial → activación del sist inmune → rta infamatoria aguda x PMN. - Episodios a repetición → reacción de granuloma de cuerpo extraño (tofo). Prevalencia ↑ con la edad. + hombres 10:1 Factores predisponentes: - Alcohol, TBQ, obesidad, ERC, leucemia, anemia hemolítica. Clasificación: 1ría 2ría	Afectación articular: Episodios recurrentes de artritis aguda, separados x períodos intercríticos. Monoartritis o poliartritis aguda - Mono articular → 1ra manif. 1ra MTF/podagra. - Poliarticular → larga evolución, 2rias, etc. - En MTF, tobillo, rodilla, muñecas, dedos manos, codos, olécranon, tendón Aquiles... - Comienzo brusco, 1ras 24hs. Remite en 3-10d, con descamación de la piel sobre la artíc. - Con el tiempo los ataques son más recurrentes y duraderos, con períodos intercríticos + cortos. - SyS inflamatorios. - Puede precederse de un “aura gotosa”. - Desencadenantes: - Inicio/cese brusco del tto, AAS, cambio en tto diurético, empeoramiento renal, deshidratación, IAM/ACV, cxs, trauma, exceso alcohol. Bursitis (+ frec: olecraneana, prealquilea). Tofos (en zonas periarticulares, TCS, olécranon, tendón de Aquiles, hélix auricular, nódulos de Heberden (IFD manos), carpo, rodilla, etc. Artropatía gotosa crónica - Sin tto → poliartritis de grandes y pequeñas articulaciones con tendencia a la simetría. Afectación renal: Nefrolitiasis (10-40%) ↑ excreción de ác úrico x orina → formación de cálculos de ácido úrico. ↑ litiasis cálcica. Nefropatía gotosa - Depósito de cristales en parénquima renal → reacción inflamatoria → fibrosis medular. Sme de lisis tumoral → IRA	LAB Hemograma, func hepática y renal. Ionograma, Ca, P. Ácido úrico en orina de 24hs. Ácido úrico: Hiperuricemia ↑ ác úrico plasmático x encima de su nivel de sat. En un pH de 7,4. 7 mg/dl → hombres. 6 mg/dl → mujeres. Causas: ↑ prod. purinas, ↓ excreción ác úrico (fcos diuréticos, AAS, ciclosporina A, laxantes, anti-TBC; IRC, nefropatía, IRA, HTA, saturnismo, hipotiroidismo, hiperPHT, acidosis láctica), hiperproducción de ác úrico (alcohol, dieta rica en purinas, hipercalórica; psoriasis, smes linfo/mieloproliferativos). Leucocitosis, neutrofilia. Muestra de líquido sinovial/tofos: - Observación de cristales de MSU es el dx de certeza. - Líqu. Sinovial inflamatorio: turbio, ↑ PMN, leve descenso de la glucosa. RX Enf crónica: lesiones periarticulares en sacabocados c/border óseos sobresalientes, y relativa conservación del espacio articular. ECO Tofos, lesiones articulares, depósito de cristales en el contorno articular. TC, RMN	Tto episodio agudo: NO FARMACOLÓGICO - Apósitos fríos, reposo. - Evitar fluctuaciones en el nivel de uricemia (evitar FR). FARMACOLÓGICO AINES - Inicio a dosis máximas e ir disminuyendo. + usados. - Diclofenac: 50mg c/8hs, ibuprofeno: 600-800 mg c/8, indometacina máx 75 mg c/12hs. Colchicina 80% eficacia si se lo administra las 1ras 12-24hs. 0,5-1 mg/d. - Se mantiene como profilaxis luego de la crisis, x 3-6 m. - Post tofos, por 12 meses. Corticoides - Ante intolerancia a AINES o colchicina, para evitar recurrencias, a dosis bajas de 5mg/d. - Prednisona 30-50 mg/d VO con reducción en 7-5d. - Betametasona o triamiclona IM de depósito. Tto hipouricemiante: En ptes con gota sintomática. Hay que mantenerla < 6 mg/dl; y en caso de tofos < 5 mg/dl. NO FARMACOLÓGICO - Evitar FR (predisponentes). FARMACOLÓGICO Se empieza el tto en período intercrisis. NO iniciar/suspender tto durante la crisis (iniciar dp de 3-12 sem post-crisis). Indicaciones: ataques a repetición q no pueden ↓ <6 mg/dl, uricosuria > 800 mg/24hs, tofos, signos rx de enf crónica, gota 2ría con uricemia elevada. - Comenzar con 1/3 de la dosis final. ↑ quincenal-mensual hasta VN ác úrico o dosis máx. Uricosúricos - Inhiben reabs. → promueven excreción renal uratos. Probenecid, sulfinpirazona, benzobromarona. Inhibidores de la xantinoxidasa ↓ producción de ácido úrico. Alopurinol → terapia VO prolongada. OJO riñón. - Dosis objetivo: 300 mg/d. Flebuxostat → Buen en riesgo renal. Dosis de 80 mg/d
Artritis por pirofosfato cálcico (pseudogota)	Cristales de pirofosfato cálcico (DPC) se depositan en el cartílago. + mujeres 2-3:1. Edad: + 50 años. Una de las ppales artropatías del anciano → >50% en personas de >90 a. Contribución genética: inicio + temprano. Otros factores: hemocromatosis, hipoMg, hiper PTH, hiperCa, hipotiroid.	Episodios de dolor intenso e inflamación en 1 o + artícul, con limitación de la actividad. Tb puede dar artritis > larga. + frec en RODILLAS, tb muñecas, hombros, tobillos, codos, manos, lig triangular carpo, sínfisis pubiana, discos intervertebrales, etc. Frecuente: ataque de artitis aguda en pte internado post-cx (la liberación de cristales atraen GB).	ECO, RX, TC, RMN - Depósitos Ca en cartílago. - Rx: calcificaciones. LAB - Cristales en líq. Sinovial.	No hay tto específico disponible. AINES Corticoides Colchicina → p/evitar nueva crisis. Hidroxiclороquina.

Fibromialgia

Es un sme de sensibilización central, que se caracteriza x alodinia generalizada.

SSC: hiperexcitabilidad de las neuronas del SNC en rta a un estímulo periférico nociceptivo, con ↑ anormal e intenso de la percepción del dolor.

2° casa + frec de consulta en reumatología (la 1°: artrosis).
Etiología desconocida.
Afecta 2-5% población, ↑ con edad.
+ mujeres 8:2
Edad: 30-50 años.
Hay relación familiar (↑ riesgo x 8,5).

Clasificación:

Tipo I	Idiopática , sin ninguna enf. concomitante.
Tipo II	Relacionada a enf. crónica . IIa → enf crónica sistémica (SS, AR). IIb → procesos locoregionales.
Tipo III	2ria a enf. psiquiátrica .
Tipo VI	Simulada . Objetivo: lograr ausentismo laboral. Evaluar "puntos testigo" del dolor: 1/3 distal del dorso del antebrazo der., punto medio del dorso 3er MTT der.

El Dx es clínico:

1. Dolor crónico gralizado x >3 m en los 4 cuadrantes.
2. Ausencia de otra enf. q pueda causar el dolor.
3. Puntos dolorosos, al menos 11 de los 18.

DD:

De origen central → sme fatiga crónica, sme miofascial, sme de sensibilidad qca múltiple, SII, DTM.

Con otras enfermedades → OA, LES, AR, polimialgia reumática, miopatías, espondilitis anquilosante, hipotiroid, etc

100%:

- **Dolor musculoesquelético generalizado.**
 - > 3 meses, en los 4 cuadrantes del cuerpo.
 - Intenso, quemante, penetrante.

73-85%:

- **Tnos del sueño.**
- **Fatiga.**
- **Rigidez matinal.**

45-59%:

- **Parestesias, cefalea, ansiedad, depresión, tnos de pánico.**
- **Cistitis intersticial.**

< 35%:

- Parestesias de miembros.
- Sensación de manos hinchadas ("pseudo-Raynaud").
- Hipersensibilidad: luz, sonidos, olores, cambios climáticos.
- Sequedad de mucosas, acúfenos.
- Alt. del ritmo intestinal.
- Tnos vasomotores.
- Disfunción cognitiva.
- Fibrofog.

Cuadros asociados:

- Sme de dolor miofacial.
- Disfunción temporomandibular y dolor facial.
- Cistitis intersticial.
- Sme de fatiga crónica (fatiga > 6 m).



El tto es sintomático.

NO FARMACOLÓGICO

- **Educar/informar**
 - Evitar desencadenantes, favorecer alivantes.
- **Terapia cognitivo-conductual**
- **Ejercicio físico**
 - 20-30 min, 2-3 veces/sem.
 - De relajación, estiramiento, aeróbicos, fuerza...

FARMACOLÓGICO

- **Antidepresivos**
 - **Tricíclicos** → amitriptilina.
 - o Dosis inicial 10-25mg/d → 50 mg/d.
 - **ISRS** → citalopram, escitalopram, fluoxetina, paroxetina, sertralina.
 - o P/mejorar depresión y ansiedad.
 - o Manejo con psiquiatra.
 - **Duales (SNRI)** → duloxetina, milnacipán.
 - o Inhiben recaptación serotonina y NA.
- **Anticonvulsivantes**
 - Pregabalina (hasta 600 mg/d).
 - Gabapentina (300-2400 mg/d).
- **Relajantes musculares, opiáceos**
 - Ciclobenzaprina
 - o Relajante muscular, mejora tnos del sueño y dolor.
 - o Uso a corto plazo, evitar en ancianos.
 - Tramadol
 - o Asoc a paracetamol, como 2° línea para el tto del dolor.
 - Paracetamol
 - No se recomienda el uso de AINEs en la FM.